



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : دينا محمد محمود عفيفي ابراهيم

المحافظة : القليوبية الحي / المدينة : القناطر الخيرية العنوان : ممم

رقم البطاقة : 27908011407122 رقم التليفون : 01003048017 تاريخ تسجيل الإستمارة : 10-10-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 01-08-1979 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /..... /د. /..... /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: دينا محمد محمود عفيفي ابراهيم National ID: 27908011407122	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

2

جمهورية مصر العربية
سلطة تنظيم الأسرة

هنا
محمد محمود عطفي إبراهيم
١٤ القسم المتكود عدائلي
مركز التطوير القيادية - القنوية

٢٧٩٠٨٠١١٤٠٨١٢٣

JX9060957



٢٧٩٠٨٠١١٤٠٨١٢٣

هنا
محمد محمود عطفي إبراهيم
١٤ القسم المتكود عدائلي
مركز التطوير القيادية - القنوية



MDT FORM

5/18/2025 G

Name	دنيا محمد رشيد	MRN	1911-2024
Age	45 y.o	ID	CV9.A.114.411-C
Menopausal status		Phone	0100348015
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	
CO morbidity	DM hysterectomy - cholecystectomy - appendectomy - ovarian cystectomy	REASON OF MDT	
Clinical Data			
BX: IDC		R: invasive CT ₃ N ₁ Mo L	
ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
7/8	8/8	3	
Sonomammography:			
Mets Workup:		TNM	
Hx of hysterectomy 2 years ago Ptn took 2 cycles NACT TXT/		Cisplatin & 2phazgu	
Then I can admission date		Alc & electrolyte	
Recommendations:			
discontinue.			
MRI brain: free of Mets.			
4/8/2025:- FSH 17: E ₂ :57			
for Zoladex 10.8			
MDT OUTCOME & PLAN			
- To add Zoladex to AT			

SIGNATURE					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د. محمد رشيد					

Name: دينا محمد محمود عفيفي		
MR. : 6297		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is a 46-year-old individual with a history of right-sided breast invasive ductal carcinoma, estrogen-receptor score 7/8, progesterone-receptor score 8/8, HER2 +3, clinical stage T3 N1 M0. The patient underwent a hysterectomy one year prior. Neoadjuvant chemotherapy with TAXOTERE and CISPLATIN was initiated but was discontinued due to intolerance, which was complicated by acute kidney injury requiring ICU dialysis, severe peripheral neuropathy, and an episode of atrial fibrillation. Following neoadjuvant therapy, the patient received a single cycle of PHESFO with an ejection fraction of 30 %, then proceeded to radiation therapy, wide local excision, and sentinel lymph node biopsy in September 2024 (pathologic stage T2 YPN0). Adjuvant therapy with PHESGO was administered, followed by maintenance therapy with an aromatase inhibitor (AI) and ZOLADEX beginning in October 2024. Calcium supplementation with calcium-one-alpha and a dental assessment for ZOMETA were also documented. The patient continued on FEMARA and ZOLADEX, with FEMARA initiated in October 2024 and planned for a three-month course. ZOLADEX dosing was scheduled according to the pharmacy record dated 25 April 2024. The current regimen consists of ZOLADEX, FEMARA, and supportive care, to be continued for three months with the next clinic visit scheduled for 3 October 2026. The patient remains on this therapy without any additional cycle or week markers documented.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 20-09-2026
	الطبيب المعالج : ايه مدحت بدوي محمد	
يعتمد ,		



Ministry of Health, Kingdom of Saudi Arabia
National Cancer Institute

الوزارة الصحية
المعهد الوطني للسرطان



MDT form

MDT form

1- Name : **د. محمد محمود علي**

Sex:

Female

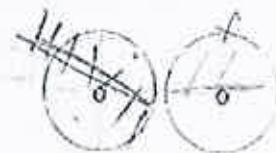
Old Hist:

Old Hist:

1911-2024

2- ID number:

Patient Age: 45 Y



Family history

Family history

Family history

0100318015

Old Hist

Reason of Ref:

Medical status

Medical status

Group

Use of Ref:

Neoplasia

Neoplasia

Old Hist

17/10/2024

dm, hysterectomy
cholecystectomy
appendectomy
ovarian cystectomy

Clinical data

Breast Imaging:

MRI breast: 15/5/2024: 7-9 o'clock hypochointic irregular speculated solid mass lesion 10 x 6 cm with extensions BIRADS 6

Mets Workup:

BX

TOC

ER

7/8

PR

8/8

Her 2 Neu

3

SISH

Ki67

T

3

N

1

M

0

Sonomammography

15/5/2024: rt breast UOQ 7-9 o'clock hypochointic irregular speculated solid mass lesion 10 x 6 cm with suspicious microcalcification 2 mm from skin with subsequent skin indentation & INTRADUCTAL EXTENSION TOWARDS NIPPLE ACCORDING TO MRI

PATIENT HISTORY

h/o hysterectomy 1 year ago

THE PT TOOK 2 CYCLES HECADOL CHemo TAXOTERE / CISPLATIN last 17/8 developed AKI > ICU & dialysis 1 times after then developed severe peripheral neuropathy & lower limb numbness with blurring of vision

mRI of brain : free of mets

took phesgo only 25/8 WAS FREE ON EXAMINATION

RT NIPPLE MASTECTOMY, CLND:VP2(1CM) VPH0

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

1- ZOLADEX AL, LH FSH, E2

2- PHESGO

3- PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Patient Name	: الأستاذة / دنيا محمد محمود علي	Request No.	: 13003965
Patient No.	: 27908011407122	Request Date	: 05/06/2024
Path No.	: SR-720/24	Verification Date	: 09/06/2024
Sex	: Female	Financial Category	: فئة الدولة - اورام خارج السلام
Age	: 44 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer & indeterminate axillary lymph node.

Nature of Specimen:

- Right breast mass, Slides revision (U/S guided core biopsy).
- Axillary lymph node, Slides revision (U/S guided FNAC).

Gross Examination

- Right breast mass: One paraffin block labelled as (200825), together with four slides, including three immunostained slides for (ER, PR & Her-2) and one H&E stained slide.
- Axillary lymph node: One paraffin block labelled as (200370), together with three slides, including one cell block & two films.

Microscopic Examination:

- Right breast mass, Slides revision (U/S guided core biopsy):
- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): Grade II (3+2+2).
- DCIS: Focally detected.
- Angiolinvasion: Not detected.
- Perineural invasion: Not detected.
- IPT:
- ER: Moderate nuclear reaction in 80 % of tumor cells (score 7/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 70 % of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 3+).
- Axillary lymph node, Slides revision (U/S guided FNAC):

Cytological examination of the smears & cell block received revealed many lymphocytes &

Verified by :
Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 09/06/2024 11:50:35

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

Patient Name	: الأستاذة / دنيا محمد محمود شوقي	Request No.	: 13003965
Patient No.	: 27908011407122	Request Date	: 05/06/2024
Path No.	: SR-720/24	Verification Date	: 09/06/2024
Sex	: Female	Financial Category	: فئة الدولة - فورم دة السلام
Age	: 44 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

macrophages among eosinophilic background. No epithelial elements detected.

Diagnosis:

- Right breast mass, Slides revision (U/S guided core biopsy):
- Invasive duct carcinoma, Grade II, With focal DCIS.
- IPT:
- ER: Positive (score 7/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Axillary lymph node, Slides revision (U/S guided FNAC):
- Smears & Cell block, trace of metastatic tumor deposits.

Signature
Prof. Dr. Lobna Omar.
Jr. Rana Fathy.

Verified by :
Dr. Duaa Mohamed

Printing Date : 09/06/2024 12:50:35

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

قسم الباثولوجي - معمل الباثولوجي - مبنى (1) - طابق الأرض - مبنى (1) - طابق الأرض - مبنى (1) - طابق الأرض
Room No. (1) - First Floor Building No. 987 - Nile Corniche - Miss El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name: Dina Mohamed Mahmoud Ahy	Date: 21/08/2024
Exam: C T BRAIN	Age: 45 Year(s)
Medical ID:	Pat ID: 77524

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE BRAIN: -

Findings:

- No focal cerebral area of abnormal density seen.
- Preserved normal gray-white matter interface.
- No extra-axial or intra-cerebral areas of fresh blood densities.
- Normal size and configuration of the ventricular system.
- No midline shift.
- Unremarkable posterior fossa structures.
- No fracture lines seen.
- Bilateral ethmoidal and maxillary, sphenoidal sinusitis and left otomastoiditis.

OPINION:

- Normal non-enhanced CT scan of the brain.

Dr. Rehab Anwar, FRCR, MD